我的乾眼症用了人工淚液還是不舒服，接下來有哪些選擇？

醫病共享決策輔助工具（草案 v3）

基隆長庚紀念醫院 眼科部 病歷號：_____

姓名：_____

填寫人：☐ 本人 ☐ 家屬（關係：　　）

日期：_____

一、先了解一下：乾眼症是什麼？

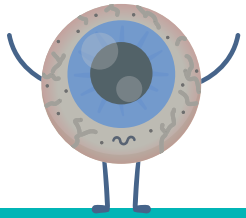
我們的淚水其實有**三層**：

淚膜分層	作用	出問題時
油脂層（最外層）	像一層保鮮膜，防止淚水蒸發	眼瞼邊緣的油脂腺阻塞，淚水很快蒸發
水液層（中間）	提供水分與養分	淚水分泌不夠，常和眼睛表面發炎有關
黏液層（最內層）	讓淚水均勻附著在眼睛表面	淚水無法平均分布

大多數人不只一層出問題，所以治療常常需要搭配。醫師會依您的檢查結果，告訴您這次需要加強哪個部分。

請先記得：

- 乾眼症是**慢性**疾病，就像皮膚乾燥一樣需要長期照顧，治療目標是**減輕不適、保護眼睛表面**，很少能一次根治
- 多數治療需要**數週到數個月**才看得出效果
- 治療**可以組合、也可以更換**，這次的選擇不是一次定終身
- 用電腦或手機時記得多眨眼、每 20 分鐘讓眼睛休息，避免冷氣或風扇直吹



每個人都適用的基礎照護

1 熱敷：一天 1–2 次，每次約 10 分鐘

- 用有醫療器材許可證的恆溫熱敷眼罩，溫度約 40–45°C
- 或用乾淨毛巾泡熱水（像泡溫泉的溫度，不燙手）擰乾，敷在閉上的眼皮上 1–2 分鐘，冷了再換，重複 5–6 次
- 熱敷前先拿下隱形眼鏡，**不要壓眼球**



2 清潔眼瞼：每天早晚各一次，熱敷後進行

- 清潔前先洗手、拿下隱形眼鏡；**兩眼不要用同一張棉片**

1. 用棉片沾眼部清潔液，或直接使用單片包裝的清潔棉片
2. 輕閉雙眼，把棉片**敷在睫毛根部 1–2 分鐘**，軟化分泌物後向下擦掉
3. 張開眼睛，**由眼頭往眼尾單一方向**擦拭上、下睫毛根部，不要來回擦
4. 繼續閉眼，輕輕擦拭眼睛周圍

- 平常記得定期清洗枕頭套、床單等寢具
- 看影片學：https://www.youtube.com/watch?v=irRL7aTB9sA

3 眨眼練習：每天 15 次

- 閉眼數 5 秒 ➡ 用力閉緊數 5 秒 ➡ 張開，算一次
- 上下眼皮一定要碰在一起才算完整眨眼
- 看手機、電腦時特別容易忘記眨眼，可以搭配喝水的時間一起做

4 人工淚液：持續使用作為基礎保養（品項與價格見常見問題 Q2）

【醫師勾選蠕形蟎時顯示】睫毛根部癢、有白色碎屑？

可能是睫毛上有「蠕形蟎」。請改用除蟎專用的清潔液（OUST Demodex 眼部清潔液），每天早晚各清潔一次，並記得定期清洗寢具。

本院可購買的居家護理用品（自費）

品項	用途	使用方式	價格
OUST Demodex 眼部清潔液	除蟎、清潔	每天早晚各 1 次，或依醫師建議	800 元／50 ml
OCuSOFT 眼視潔 眼部清潔舒效包	日常眼瞼清潔（單片包裝）	每天早晚各 1 次，或依醫師建議	800 元／30 片
正杏 動力式熱敷墊	眼部熱敷	一天 2–3 次	1,800 元

二、對您來說，什麼比較重要？

1. 對自費治療的接受程度？

☐ 希望完全使用健保　☐ 可以接受部分自費　☐ 效果優先，費用不是主要考量

2. 每天花 10–15 分鐘熱敷和清潔眼瞼，您做得到嗎？

☐ 可以，每天都能做到　☐ 偶爾會忘記　☐ 很難持續

3. 您希望症狀多快改善？

☐ 越快越好　☐ 可以等 1–3 個月　☐ 不急，穩定最重要

4. 需要到醫院做處置（例如雷射、放淚管塞、抽血製作眼藥水），您能接受嗎？

☐ 可以接受　☐ 視情況，想再了解　☐ 希望盡量不要

5. 您目前是否懷孕、哺乳或計畫懷孕？

☐ 是　☐ 否

三、我是「油脂分泌不良」的乾眼症，需加強「油脂層」

眼瞼邊緣有一排「瞼板腺」，負責分泌油脂蓋在淚水表面。當這些腺體阻塞或發炎，淚水就容易蒸發，眼睛變得乾澀、灼熱、早上眼屎多、視力時好時壞。

	加強居家護理	**IPL 脈衝光治療**	**口服藥物（doxycycline）**
			
怎麼做	確實執行每天熱敷、清潔眼瞼、眨眼練習	在診間以脈衝光照射眼瞼下方皮膚，再由醫師擠壓瞼板腺	低劑量口服四環黴素類抗生素，利用其抗發炎作用
療程	每天執行，長期持續	可以**先做 1 次看效果**；也有醫師安排連續 5–6 次，每次間隔 1–1.5 個月，**實際次數可依預算與醫師討論**	數週到數個月
多久見效	數週	多數人**做 1 次就有部分改善**	數週
優點	不花錢、沒有副作用	不需每天自己做，部分人改善明顯	方便，健保給付

	加強居家護理	IPL 脈衝光治療	口服藥物 (doxycycline)
			
缺點	很花時間，需要每天自律；停止後容易復發	自費；效果因人而異，需要追加維持	可能腸胃不適、對陽光敏感
不適合的情況	-	膚色較深、近期曬傷、正在使用光敏感藥物、照射部位有皮膚病灶	**懷孕、哺乳**、對該類藥物過敏
費用	免費 (用品可自備或自費購買)	**自費 6,000 元／次；** 若做 5–6 次，總計約 30,000–36,000 元	健保

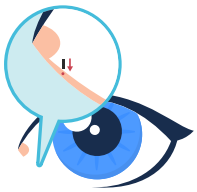
重點提醒： IPL 和口服藥都**不能取代居家護理**，熱敷與清潔仍要持續，效果才會好；IPL 的效果可以維持一段時間，但**不是永久痊癒**。

A1. 以下哪些是您願意考慮的？（可複選）

☐ 加強居家護理 ☐ IPL：先試 1 次 ☐ IPL：完整療程 ☐ 口服藥物 ☐ 還不確定

四、我是「淚液不足／眼表發炎」的乾眼症：加強「水液層」與抗發炎

您的眼睛**分泌的淚水量不夠**，常和眼睛表面的慢性發炎有關。人工淚液只能暫時補充水分，當它不夠時，就需要進一步處理「發炎」或「讓淚水留久一點」。

	抗發炎眼藥水（cyclosporine）	**淚管塞** 	**自體血清眼藥水** 
怎麼做	每天點藥，減少眼睛表面發炎，幫助淚腺恢復分泌	在淚水排出的小孔放入微小塞子，讓淚水留在眼睛久一點	抽取您自己的血液，離心後由醫師調製成眼藥水，含有修復眼表的天然成分
多久見效	**較慢，通常 1–3 個月**	**很快**，數天內	數週
優點	針對發炎根本原因	門診幾分鐘完成，**不適合可以取出**	適合較嚴重或其他治療無效者；一次製作約可用 2–3 個月
缺點	剛開始點會刺痛、灼熱，需耐心持續	可能脫落、少數人變得容易流眼淚	**製作當天需在醫院停留至少 3 小時**；需冷藏或冷凍保存
可能的副作用	點藥時刺痛、眼紅	異物感、塞子移位，少見感染	保存不當可能污染
費用	**健保（需事前審查）或自費 1,175 元／月**，見下方說明	【本院】 _____ 元	**自費**，主要為生理食鹽溶液（BSS）約 800 元，另加抽血費用（約千元左右）

重點提醒： cyclosporine 點了一兩個星期沒感覺是正常的，**通常要 1–3 個月才看得出效果**，請不要自行停藥，先與醫師討論。

關於 cyclosporine 的兩種取得方式：



1. **健保事前審查**：限**嚴重乾眼症**，需同時符合：
   - 淚液分泌測試少於 5 mm／5 分鐘
   - 淚膜破裂時間 5 秒以內
   - 眼睛照片顯示角膜有明顯破皮或其他嚴重病變
   - 已經使用人工淚液、淚管塞或其他抗發炎藥物一段時間仍未改善，**且病歷上需有兩次門診紀錄（間隔 1–3 個月）**

   也就是說，大多數人需要**先治療、回診 1–3 個月**後才能送審。送審後**約 1 個月回診看結果**，通過就在當次回診開藥；**不保證通過**。核准後每 6 個月需重新審查，症狀與檢查都要有改善才能繼續使用。
2. **自費**：不需審查，可以立即開始，**1,175 元／盒（30 支，約一個月）**

簡單來說：選擇健保，從送審到拿到藥大約要等 **1 個月**；選擇自費，當天就可以開始使用。

關於自體血清：製作當天的流程

1. 門診開立抽血單，批價後到 **1 樓領藥（BSS 4 罐）**
2. 拿抽血單到 **1 樓抽血櫃台**抽血
3. 回到 **5 樓眼科門診**等候，把領到的藥水交給診間
4. 血液離心後，由醫師調製成眼藥水（一次約 4 瓶，依用量約可使用 2–3 個月）

整個流程**至少需要 3 小時**，請預留時間。

自體血清怎麼保存？

狀態	保存方式
正在使用的那一瓶	冰箱**冷藏**
泡好、近期會用的	**冷藏**
泡好、1 個月後才會用的	**冷凍**
還沒稀釋的血清	**冷凍**

- 帶血清回門診時，請準備**保冷罐（裡面放冰塊，例如保溫瓶、燜燒罐）和夾鏈袋**
- **血清如果變色、變混濁，請不要再使用，並提早回診**

B1. 以下哪些是您願意考慮的？（可複選）

☐ cyclosporine（健保事審）　☐ cyclosporine（自費）
☐ 淚管塞　☐ 自體血清　☐ 還不確定

五、我的選擇

Q：我希望先從哪一項開始？

A： _____ **(病患自由填答)**

SURE 量表（是／否）

- **我對自己的選擇有把握** ☐ 是 ☐ 否
- **我了解每個選項的好處和缺點** ☐ 是 ☐ 否
- **我清楚哪些事情對我最重要** ☐ 是 ☐ 否
- **我有足夠的支持和建議來做決定** ☐ 是 ☐ 否

任何一題勾「否」，表示您還需要更多討論，請告訴醫療團隊。

六、共用說明

醫師可能另外搭配的藥物（皆為健保給付）

不論您選擇哪一種治療，醫師可能依您的狀況，再搭配以下藥物：

藥物	用途	注意事項
低濃度類固醇眼藥水 (FML 0.02%、0.1%)	短期減輕眼睛表面發炎，也可減少 cyclosporine 剛開始使用時的刺痛	**使用期間務必依約回診量眼壓**；請勿自行延長使用或停藥後又自行恢復
眼藥膏（Duratears）	睡前使用，整晚保持眼睛濕潤	點完會暫時看不清楚，**建議睡前使用**
眼用凝膠（Carbomer）	比人工淚液停留更久，適合乾澀較明顯者	點完可能短暫模糊

⚠️ **使用類固醇眼藥水的人請特別注意**：長期或自行使用可能造成**眼壓升高（青光眼）或白內障，而眼壓升高通常沒有感覺**，只能靠回診測量才知道。請一定要按時回診。

常見問題

1 吃魚油對乾眼症有幫助嗎？

大型研究顯示，補充魚油對多數乾眼症病人的改善**並不比安慰劑明顯**。如果您已經在吃、沒有不適，可以和醫師討論是否繼續。

2 人工淚液還要繼續點嗎？要選哪一種？

通常會建議繼續，作為基礎保養。以下人工淚液在本院皆為**自費**：

種類	本院品項	特點	參考價
含防腐劑（瓶裝）	淚然 Tears Naturale	一天最多點 4 次	150 元／罐
含防腐劑（瓶裝）	Systane Ultra	保濕較持久， 適合輕中度乾眼	250 元／罐
含脂質（瓶裝）	Systane Complete	補充淚膜油脂層，適 合油脂分泌不良型	420 元／罐
不含防腐劑 （單支裝）	淚然 Tears Naturale Free	可頻繁點， 較不刺激眼睛表面	380 元／盒 （32 支）
含玻尿酸（單支裝）	Optive Fusion	保濕時間較長， 適合乾澀感明顯者	330 元／盒 （30 支）
含玻尿酸	Systane Hydration	保濕、幫助眼表修復	450 元／罐

一天需要點超過 4 次的話，建議選擇不含防腐劑的單支裝，避免防腐劑反而刺激眼睛。

3 多久回診評估？

- **使用眼藥水治療：** 第一次大約 **1 個月**後回診，確認效果與副作用；穩定後改為每 **3 個月**回診一次（可開立連續處方箋）
- **IPL 療程：** 每次治療間隔約 1–1.5 個月，依醫師安排回診
- **cyclosporine 健保送審：**送審後約 1 個月回診看結果

醫師確認：本次治療＿＿＿＿＿＿＿＿　回診日期＿＿＿＿＿＿＿＿

醫師簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿　病人／家屬簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿

本工具僅供醫病討論使用，不取代醫師的臨床判斷。 版本 v3（草案）